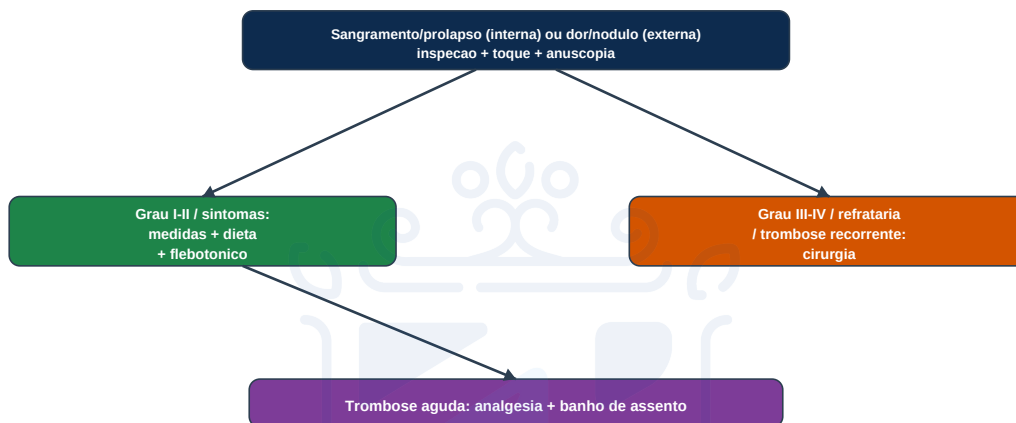


DOENÇA HEMORROIDÁRIA — GRAU GUIA CONDUTA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

HEMORROIDAS — INTERNA x EXTERNA + GRAU



INTERNA x EXTERNA

Aspecto	Interna	Externa
Localização	Acima da linha pectínea	Abaixo da linha pectínea
Revestimento	Mucosa (inervação visceral)	Anoderma/pele (inervação somática)
Sintomas	Prolapso, SANGRAMENTO, prurido	TROMBOSE, dor aguda, nodulação
Coxins (posição)	Lateral E (3h), posterior D (7h), anterior D (11h)	—

CLASSIFICAÇÃO (HEMORROIDAS INTERNAS)

Grau	Definição
Grau I	Sem prolapso (apenas abaulamento/sangramento)
Grau II	Prolapso ao esforço com retorno ESPONTÂNEO
Grau III	Prolapso ao esforço com redução MANUAL
Grau IV	Prolapso irreduzível

DEFINIÇÃO, RISCO E DIFERENCIAL

PONTOS-CHAVE

- Coxins vasculares (arteríolas + veias) sustentados por tecido conjuntivo: dão continência fina; doença = degeneração + hiperfluxo + deslizamento
- Fatores: esforço evacuatório, dieta pobre em fibras, gestação, aumento da pressão abdominal, genética, sexo masculino
- DIFERENCIAL essencial: VARIZES retais (hipertensão portal) e PROCIDÊNCIA de reto (prolapso de espessura total) — não confundir com grau IV
- Sangramento hemorroidário é vermelho-vivo, ao evacuar — sempre EXCLUIR câncer colorretal em pacientes de risco (colonoscopia)
- Pregas radiais = hemorroidas; pregas concêntricas = prolapso retal completo

TRATAMENTO CLÍNICO / PS

Rx MEDIDAS + ANALGESIA + FLEBOTÔNICO

Medidas dietéticas: fibras + hidratação para regularizar o hábito intestinal (base do tratamento)

Banho de assento (com ou sem sais): analgésico/anti-inflamatório — PODE ser feito na vigência de trombose

Analgesia: Cetoprofeno 100 mg 12/12h por 4-6 dias ($\pm$ Dipirona 1 g 6/6h)

Flebotônico: Diosmina 450 + Hesperidina 50 mg, 2-3x/dia por 7 dias

Trombose hemorroidária externa aguda: analgesia + banho de assento; excisão do trombo se < 72h e muito dolorosa

TRATAMENTO CIRÚRGICO

INDICAÇÕES E TÉCNICAS

- Indicações: refratária ao tratamento clínico, internas grau III-IV, trombose de repetição
- Excisional (PADRÃO-OURO): hemorroidectomia Milligan-Morgan (aberta) ou Ferguson (fechada) — desvantagem: dor pós-operatória
- Não excisional (internas): PPH (grampeamento do prolapso mucoso); THD (desarterialização transanal)
- Complicações da cirurgia: dor anal, estenose anal, incontinência (se lesão esfíncteriana), sangramento, infecção (atenção à GANGRENA DE FOURNIER)
- Acompanhamento com proctologia

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com ____ (sangramento/prolapso/trombose); hemorroida interna grau ____ / externa trombosada.
- Sinais de alarme/diferencial excluídos: câncer ____ (colonoscopia?), hipertensão portal ____, procidência ____.
- Conduta: medidas dietéticas, banho de assento, analgesia ____, flebotônico; trombo excisado: ____.
- Encaminhamento à proctologia (grau III-IV/refratária/trombose recorrente) para programação cirúrgica.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Hemorroida interna que prolapsa ao esforço e necessita de redução manual corresponde a qual grau?

- A) Grau I
- B) Grau II
- C) Grau III
- D) Grau IV
- E) Não classificável

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a base do tratamento clínico da doença hemorroidária?

- A) Antibiótico oral prolongado
- B) Medidas dietéticas (fibras + hidratação), banho de assento e flebotônico
- C) Corticoide sistêmico
- D) Jejum
- E) Imobilização

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o tratamento padrão-ouro para hemorroidas internas grau IV?

- A) Ligadura elástica
- B) Hemorroidectomia excisional (Milligan-Morgan/Ferguson)
- C) Apenas flebotônico
- D) Escleroterapia
- E) Dieta isolada

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente cirrótico com sangramento anal e dilatações vasculares retais. Qual diagnóstico diferencial é fundamental?

- A) Hemorroidas comuns
- B) Varizes retais por hipertensão portal
- C) Fissura anal
- D) Prolapso mucoso
- E) Condiloma

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o banho de assento na trombose hemorroidária, é correto:

- A) É contraindicado na vigência de trombose
- B) Pode ser realizado na vigência de trombose, com efeito analgésico e anti-inflamatório
- C) Substitui a cirurgia em todos os casos
- D) Só pode ser feito com antibiótico
- E) Aumenta o risco de sangramento

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Grau III = prolapso ao esforço com necessidade de redução MANUAL. Grau I sem prolapso, grau II reduz espontaneamente, grau IV é irreduzível.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A base é a regularização do hábito intestinal com fibras e hidratação, somada a banho de assento e flebotônico (diosmina/hesperidina); a cirurgia fica para graus avançados/refratários.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A hemorroidectomia excisional (Milligan-Morgan aberta ou Ferguson fechada) é o padrão-ouro, indicada em grau III-IV, refratárias e trombose de repetição; tem como desvantagem a dor pós-operatória.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Em hepatopata/cirrótico, dilatações vasculares retais podem ser varizes retais por hipertensão portal — diferencial fundamental, pois o tratamento é distinto (sutura/ligadura, manejo da hipertensão portal).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O banho de assento pode ser realizado na vigência de trombose, atuando como adjuvante analgésico e anti-inflamatório.

SM24
Suporte ao Plantão Médico